Клинические рекомендации

Болезнь Меньера

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H81.0** — Болезнь Меньера
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/18_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 3

2.3 Клиническая картина 3

2.4 Стадии 4

2.5 Степень тяжести 4

2.6 Жалобы 4

3. Диагностика 4

3.1 Диагностические критерии 5

3.2 Осмотр 5

3.3 Анализы 5

3.4 Аудиометрия и импедансометрия 5

3.5 Вестибулярные исследования 6

3.6 Лучевая диагностика 6

3.7 Дифференциальная диагностика 6

4. Лечение 7

4.1 Купирование приступа 7

4.2 Межприступный период 7

4.3 Хирургическое лечение 8

4.4 Реабилитация 8

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 8

5.1 Организация помощи 8

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности в самом тексте КР 9

1. Главное

- Достоверный диагноз ставят, если было не меньше двух самопроизвольных приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов, аудиометрия подтвердила сенсоневральную тугоухость на низких и средних частотах во время или после приступа, слух, шум и ощущение полноты в ухе колеблются, а других причин нет.
- Всем пациентам делают тональную пороговую аудиометрию, чтобы оценить степень тугоухости, и импедансометрию — тимпанометрию с акустической рефлексометрией, — чтобы исключить патологию среднего уха.
- Приступ купируют атропином или платифиллином подкожно, антигистаминными препаратами (дименгидринатом, дифенгидрамином) или бензодиазепинами (лоразепамом, диазепамом) не дольше 3 суток; из-за тошноты и рвоты лекарства лучше вводить парентерально.
- После приступа и если приступы повторяются чаще чем раз в 3 месяца, назначают бетагистин по 24 мг 2 раза в день на 2–3 месяца и дольше.
- Если консервативное лечение не помогает 6–12 месяцев, оперируют: сначала выполняют слухосохраняющие вмешательства, а деструктивные — вторым этапом или когда слух уже социально незначим.
- КТ височных костей и МРТ головного мозга с внутренними слуховыми проходами и мостомозжечковыми углами нужны, чтобы исключить опухоль, прежде всего акустическую шванному при односторонней сенсоневральной тугоухости.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Болезнь Меньера (БМ) — заболевание внутреннего уха, при котором повторяются приступы системного головокружения, а также бывают шум в ушах и сенсоневральная тугоухость.

2.2 Классификация

По классификации Американской академии оториноларингологии и хирургии головы и шеи (AAO-HNS) выделяют четыре формы болезни: несомненную, достоверную, вероятную и возможную.

Болезнь начинается по-разному. При кохлеарной форме сначала появляются слуховые расстройства, а затем вестибулярные. При классическом варианте они возникают одновременно: уже первый приступ головокружения сопровождается снижением слуха и шумом в ухе. Реже встречается вестибулярная форма, когда сначала бывают только приступы головокружения, а слуховые расстройства присоединяются позже.

По данным разных авторов, колебания слуха сочетаются с головокружением у 82,7% пациентов и бывают без головокружения у 17,3%; по другим данным, болезнь начинается только со слуховых симптомов у 54,4%, а классически — у 45,6%.

2.3 Клиническая картина

Типична триада: приступы системного головокружения, шум в ухе и тугоухость. Приступ начинается внезапно, в любое время суток и года, на фоне полного здоровья и ничем не провоцируется. Иногда ему предшествует аура — появление или усиление заложенности и шума в больном ухе. Приступ всегда сопровождается вегетативными симптомами, прежде всего тошнотой и рвотой, длится несколько часов, чаще 4–6, и проходит сам, без лекарств. Шум в ухе односторонний, чаще низко- или среднечастотный, он усиливается перед приступом и во время него.

Тугоухость обычно односторонняя и колеблется. При аудиологическом исследовании находят так называемую скалярную, или ложную сенсоневральную, тугоухость: горизонтальную или восходящую аудиометрическую кривую с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах. Пороги восприятия ультразвука нормальные, а сам ультразвук латерализуется в хуже слышащее ухо.

2.4 Стадии

Первая, начальная стадия. Приступы редкие — 1–2 раза в год или даже раз в 2–3 года — и длятся в среднем 1–3 часа, с тошнотой и рвотой. Шум, заложенность или распирание в ухе появляются до или во время приступа, но постоянными не бывают. Характерны колебания слуха: он снижается, как правило, перед приступом и затем улучшается. Некоторые пациенты замечают, что сразу после приступа слух заметно лучше, а в течение суток снова возвращается к обычному уровню.

Вторая стадия — разгар болезни. Приступы становятся типичными, с интенсивным системным головокружением и выраженными вегетативными симптомами, и повторяются от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю или ежедневно. Шум в ухе беспокоит постоянно и усиливается во время приступа, заложенность и дискомфорт в больном ухе бывают каждый день, слух снижается от приступа к приступу.

Третья, затухающая стадия. Типичные приступы становятся реже или прекращаются, но пациента постоянно беспокоят шаткость и неустойчивость. Слух на больное ухо значительно снижен, и часто в процесс вовлекается второе ухо. Возможны отолитовые кризы Тумаркина — внезапные падения из-за резкого смещения отолитовых рецепторов и внезапного включения вестибулярных рефлексов; они могут приводить к серьёзным травмам.

> Длительность приступа в КР указана по-разному: в общем описании клинической картины — несколько часов, чаще 4–6, для первой стадии — в среднем 1–3 часа, а в диагностических критериях — от 20 минут до 12 часов.

2.5 Степень тяжести

По частоте и длительности приступов и по сохранности трудоспособности выделяют три степени тяжести. При тяжёлой приступы ежедневные или еженедельные, длятся несколько часов со всем комплексом статокинетических и вегетативных расстройств, и трудоспособность потеряна. При средней приступы еженедельные или ежемесячные, тоже по нескольку часов, статокинетические расстройства умеренные, вегетативные выражены, трудоспособность теряется во время приступа и на несколько часов после него. При лёгкой приступы короткие, а ремиссии длятся месяцы или годы.

2.6 Жалобы

Пациенты жалуются на приступы нарастающей глухоты, шум в ушах, периодическую потерю равновесия, головокружение, тошноту вплоть до рвоты.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по критериям AAO-HNS (редакции 1972, 1985 и 1995 годов) и по критериям 2015 года, которые согласовали Общество Барани, Европейская академия отологии и нейроотологии (EAONO), комитет по равновесию AAO-HNS и Корейское общество равновесия.

3.1 Диагностические критерии

Форма	Критерии
Несомненная	Эндолимфатический гидропс подтверждён гистологически; не меньше двух приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов; сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; колеблющиеся слуховые симптомы — слух, шум, ощущение полноты в ухе.
Достоверная	Не меньше двух самопроизвольных приступов головокружения длительностью от 20 минут до 12 часов; сенсоневральная тугоухость на низких и средних частотах, подтверждённая аудиометрией во время или после приступа; колеблющиеся слуховые симптомы; других причин нет.
Вероятная	Хотя бы один приступ головокружения; сенсоневральная тугоухость, подтверждённая хотя бы однократной аудиометрией; шум или заложенность в больном ухе; других причин, объясняющих симптомы, нет.
Возможная	Приступы головокружения без подтверждённого снижения слуха либо стойкая или непостоянная сенсоневральная тугоухость с нарушением равновесия, но без явных приступов головокружения; других причин, объясняющих симптомы, нет.

3.2 Осмотр

Пациента обследуют комплексно, с участием терапевта и невролога. Проводят акуметрию — исследуют слух шёпотной и разговорной речью, ставят камертональные пробы Вебера, Ринне и Федериче. Оценивают спонтанный нистагм, выполняют тест импульсного (быстрого) поворота головы (тест Хальмаги — Кертойза), статокоординаторные и статокинетические пробы — позу Ромберга, пробу Фишера — Барре, ходьбу по прямой и фланговую походку, пробу на диадохокинез — и позиционные пробы: пробу Дикса — Холлпайка и roll-тест Пагнини — Макклюра.

3.3 Анализы

Для дифференциальной диагностики делают общий и биохимический общетерапевтический анализы крови.

3.4 Аудиометрия и импедансометрия

Всем пациентам проводят тональную пороговую аудиометрию, чтобы определить степень тугоухости.

Всем пациентам проводят импедансометрию — тимпанометрию и акустическую рефлексометрию, — чтобы исключить патологию среднего уха.

Чтобы подтвердить гидропс лабиринта при клинических признаках вероятной болезни Меньера, а также если консервативное лечение не помогает, определяют пороги чувствительности к ультразвуку и его латерализацию, проводят электрокохлеографию (ЭКоГ) или дегидратационный тест — по отдельности или в сочетании.

Вызванную отоакустическую эмиссию и коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) исследуют, если МРТ головного мозга противопоказана, например из-за металлических конструкций в теле, и если результаты тональной аудиометрии сомнительны — при подозрении на аггравацию или симуляцию.

На аудиограмме при болезни Меньера видна скалярная, или ложная сенсоневральная, тугоухость: горизонтальная или восходящая кривая с костно-воздушным интервалом 5–10 дБ на низких или средних частотах. Пороги ультразвука нормальные, ультразвук латерализуется в хуже слышащее ухо. Амплитуда пиков спонтанной отоакустической эмиссии может быть снижена.

Если поражение ретрокохлеарное, пороги акустического рефлекса повышены по сравнению с нормальными порогами слышимости.

О ретрокохлеарной дисфункции по КСВП говорят отсутствие всех пиков с I по V, которое трудно объяснить потерей слуха; отсутствие всех пиков после I или после III; удлинение межпикового интервала I–V больше 4,4 мс; снижение отношения амплитуд V/I ниже 0,5, особенно вместе с другими изменениями. Диагностическое значение имеет и патологически большая разница параметров между правым и левым ухом, особенно межпиковых интервалов, если её трудно объяснить односторонней или асимметричной тугоухостью периферического уровня.

Универсального способа выявить гидропс лабиринта нет. Чтобы подтвердить диагноз, нужен широкий набор исследований с оценкой в динамике, а их результаты сильно зависят от стадии болезни.

3.5 Вестибулярные исследования

Вестибулометрию проводят для дифференциальной диагностики, если диагноз не удаётся установить по клинической картине, и при планировании операции.

Между приступами спонтанных вестибулярных симптомов нет, статическое и динамическое равновесие в норме, в том числе при постурографии (стабилографии). Во время приступа развивается периферический вестибулярный синдром: системное головокружение, тошнота, рвота, нарушение равновесия и горизонтальный вестибулярный нистагм. Вестибулометрия в межприступном периоде показывает угнетение вестибулярной функции, сильнее выраженное на больной стороне.

По тем же показаниям — для дифференциальной диагностики и перед операцией — проводят видеонистагмографию (ВНГ) с записью калорической или вращательной пробы, видеоимпульсного и других тестов.

3.6 Лучевая диагностика

Выполняют компьютерную томографию височных костей и магнитно-резонансную томографию головного мозга с выведением внутренних слуховых проходов и мостомозжечковых углов, в том числе с контрастированием.

Так исключают опухоли (при односторонней сенсоневральной тугоухости — прежде всего акустическую шванному), демиелинизирующий процесс, нейроваскулярный конфликт, приобретённые и врождённые структурные изменения височных костей.

3.7 Дифференциальная диагностика

Диагноз	Отличительные признаки
Болезнь Меньера	Приступы системного головокружения со снижением слуха, распиранием и шумом в ухе, тошнотой и рвотой
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)	Короткие приступы системного головокружения при изменении положения тела
Вестибулярный нейронит	Сильнейшее вращательное головокружение, расстройство равновесия, тошнота и рвота на фоне вирусной инфекции
Перилимфатическая фистула	Головокружение разной силы и расстройства слуха вплоть до глухоты после травмы уха или при хроническом отите; провоцируются изменением давления или громкими звуками
Инфаркт лабиринта	Острое системное головокружение, часто вместе с острой односторонней глухотой и шумом в ухе

Диагноз	Отличительные признаки
Аутоиммунные заболевания внутреннего уха	Преимущественно вестибулярное прогрессирующее головокружение с двусторонним снижением слуха и другими признаками аутоиммунного заболевания
Вестибулярная мигрень	Головная боль по типу мигрени при части приступов головокружения

4. Лечение

Лечение складывается из трёх частей: купирования приступа головокружения лекарствами, лекарственной профилактики в межприступный период и хирургического лечения.

4.1 Купирование приступа

Чтобы купировать острый приступ вестибулярного головокружения, подкожно вводят #атропин или #платифиллин: они блокируют импульсы от раздражённого лабиринта. Знак # означает применение вне инструкции.

Для купирования приступа применяют также дименгидринат или дифенгидрамин.

Это H1-антигистаминные препараты, которые проникают через гематоэнцефалический барьер и действуют как центральные вестибулярные блокаторы. Их используют в первые сутки приступа, максимум до 3 суток.

В первые сутки острого головокружения, максимум до 3 суток, для купирования приступа можно использовать #лоразепам или #диазепам.

Из-за тошноты и рвоты во время приступа лекарства лучше вводить парентерально, а когда симптомы стихнут, можно перейти на таблетки.

Препарат	Доза
#Атропин	1 мл 0,1% раствора подкожно
#Платифиллин	2 мл 0,2% раствора подкожно
Дименгидринат	50–100 мг 2–3 раза в сутки
Дифенгидрамин	25–50 мг внутрь 3–4 раза в сутки; внутримышечно — #дифенгидрамин 10–50 мг
#Лоразепам	1 мг, можно сублингвально
#Диазепам	10 мг внутримышечно

4.2 Межприступный период

После приступа головокружения, а также если между приступами проходит меньше 3 месяцев, назначают бетагистин по 24 мг 2 раза в день (48 мг в сутки) на 2–3 месяца и дольше.

Бетагистин улучшает кровообращение в сосудистой полоске внутреннего уха, снижает возбудимость нейронов вестибулярных ядер и ускоряет восстановление вестибулярной функции, в том числе за счёт центральной компенсации.

Курсами назначают диуретики — калийсберегающие, тиазидные и другие — или ингибиторы карбоангидразы, оптимально ацетазоламид. В КР приведён пример схемы: в 1–3-й день по 1 таблетке 2 раза в день (утром и днём), в 7–9-й и 13–15-й дни — по 1 таблетке утром. Курс подбирают индивидуально.

Петлевые диуретики не применяют из-за возможной ототоксичности. При длительном приёме ацетазоламида контролируют электролиты крови и при необходимости восполняют потери.

Всем пациентам назначают диету: соль ограничивают до 2 г в сутки, исключают глутамат натрия, питание делают сбалансированным, чтобы нормализовать прежде всего водно-солевой обмен.

Соли и готовых продуктов должно быть как можно меньше; алкоголь, кофеин и никотин исключают, жидкость пьют умеренно.

В плановом порядке проводят инфузионную дегидратационную терапию: в первые 2 года болезни — раз в 6–12 месяцев, затем — раз в 2–3 года. Конкретные препараты КР не называет.

4.3 Хирургическое лечение

Оперируют, если консервативное лечение не помогает в течение 6–12 месяцев.

На первой и второй стадиях первым этапом выполняют слухосохраняющие вмешательства: хордоплексустомию, интратимпанальное введение глюкокортикоидов, обнажение (дренирование) эндолимфатического мешка или селективную лазеродеструкцию ампулярного рецептора горизонтального полукружного канала.

Деструктивные вмешательства — интратимпанальное введение гентамицина, лазеродеструкцию лабиринта, вестибулярную нейроэктомию — выполняют вторым этапом, если слухосохраняющая операция не помогла, или если слух уже социально незначим.

4.4 Реабилитация

При нарушении равновесия в межприступном периоде на третьей стадии назначают лечебную физкультуру для коррекции вестибулярной функции. При двусторонней хронической нейросенсорной тугоухости, если средние пороги на речевых частотах на лучше слышащем ухе выше 31 дБ, проводят слухопротезирование.

Если на фоне хронической вестибулярной дисфункции развиваются соматоформные расстройства, проводят психолого-социальную реабилитацию.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов с болезнью Меньера ставят на диспансерное наблюдение и осматривают раз в год, чтобы оценить эффект лечения и проконтролировать слух и вестибулярную функцию.

Для профилактики КР называет здоровый образ жизни, раннее выявление воспалительных заболеваний ЛОР-органов, особенно у детей, и предупреждение рецидивов хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов путём диспансерного наблюдения.

Пациенту советуют избегать резких перепадов давления в среднем ухе — при подводном плавании, резком сморкании, авиаперелётах. В еде ограничивают углеводы, солёное, острое и жирное мясное, каждый день едят продукты, богатые калием, например печёный картофель, творог, курагу. Исключают алкоголь, курение, кофеин и продукты с консервантами, особенно с глутаматом натрия. Нужно избегать переутомления, работы на высоте и с движущимися предметами.

5.1 Организация помощи

Первичную специализированную помощь оказывает оториноларинголог в поликлинике.

При тяжёлом состоянии пациента госпитализируют в оториноларингологическое отделение; при тяжёлом течении — по скорой помощи сразу в специализированное ЛОР-отделение, минуя поликлинику.

Выписывают, когда приступы головокружения прекратились или стали реже, либо пороги слуха улучшились или стабилизировались.

На течение и исход болезни влияют её длительность и тяжесть, сопутствующие заболевания, возраст пациента, наличие и характер осложнений.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Болезнь Меньера»
Версия	2-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	На титульном листе КР указано «пересмотр не позднее 2026 года»; в приложении А2 — обновление каждые 3 года
Код в рубрикаторе	18_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Длительность приступа указана по-разному: в описании клинической картины — «чаще 4-6 ч.», для первой стадии — «в среднем от 1 до 3 часов», в диагностических критериях — от 20 минут до 12 часов.
- Срок пересмотра не согласован: на титульном листе — «пересмотр не позднее 2026», то есть через 2 года после утверждения, а в приложении А2 — обновление «каждые 3 года».
- В критериях качества у обследований стоит УДД 4, а у тех же рекомендаций в разделе 2 — УДД 5.
- Схема ацетазоламида дана в таблетках без дозы в миллиграммах.
- Для плановой инфузионной дегидратационной терапии (раздел 6) не названы препараты и не указаны УУР и УДД; уровней нет и у рекомендаций по хирургическому лечению и диспансерному наблюдению.
- Профилактика сформулирована через воспалительные заболевания ЛОР-органов «особенно в педиатрической практике», хотя КР адресована взрослым, а воспаление среди причин болезни не названо.
- Опечатки: «импендансометрии» вместо «импедансометрии», «Н3-гистаминовых» вместо «Н3-гистаминовых».